

Применение схемы R CHOP-14 при лечении В-клеточных индолентных неходжкинских лимфом

Каракулов Р.К., Габбасова С.Т., Сагиндыков Г.А., Асанов А.А., Насипов Б.А., Джазылтаева А.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Заболеваемость неходжкинскими лимфомами (НХЛ) значительно выше в развитых странах (увеличилась более чем на 50% за последние 20 лет). Злокачественные лимфомы в Республике Казахстан в структуре онкопатологии занимает 8 ранговую позицию составляя 4,2 на 100 000 населения. В РК ежегодно регистрируется около 500 первично диагностированных НХЛ, около 350 погибает в первый год регистрации. Самые высокие показатели заболеваемости этой формой опухоли установлены в СКО (16,3‰), Павлодарской - 14,2‰, а по смертности – Мангыстауская - 7,6‰, СКО – 7,1‰, Павлодарской – 7,1‰ и ВКО – 7,0‰ областей.

Пятилетняя выживаемость больных НХЛ в среднем не превышает 48-50% (Арзыкулов Ж.А. и др, 2009).

Выделены две основные группы НХЛ: высокой степени злокачественности (агрессивные) и низкой степени (индолентные), последние составляют около 60% из всех лимфом. Индолентные лимфомы характеризуются длительным течением с периодами рецидива и ремиссии, а также устойчивостью к химиопрепаратам.

При рецидивах и резистентных формах НХЛ весьма перспективным оказалась применение моноклональных антител (МКА) – мабтеры, особенно при фолликулярной лимфоме. Пятилетняя выживаемость больных с индолентной формой НХЛ широко варьирует в зависимости от морфоиммунологического варианта опухоли. Наибольшая эффективность достигнута у больных фолликулярными лимфомами – 60,0%, при средней продолжительности ремиссии 11 мес. В нескольких исследованиях добавление мабтеры к режиму СОР и CHOP позволило добиться полной ремиссии у 75,0% больных (Поддубная И.В., (2004).

Нами впервые при лечении индолентных форм НХЛ использована модернизированная схема R CHOP-14.

Цель исследования

- улучшение результатов лечения больных с индолентной формой НХЛ.

Дизайн и методы исследования

- методом информированного согласия пациентов и рандомизации проводилось квазиисследование (n=15)) с индолентной формой НХЛ П-1У А и Б стадий заболевания проводилось лечение с применением модернизированного метода схемы ПХТ R CHOP-14 (ритуксимаб по 350 мг/м², 1 дни, ЦФ 750 мг/м², доксорубин 50 мг/м², винкристин 1,4 мг/м², 2 день, преднизалон 40 мг/м² внутрь 1-5 дни), цикл повторяется через каждые 14 дней. Всего проведено 6-8 курсов ПХТ.

Контрольную группу эквивалентную основной составила (n=15) пациентов с индолентными формами НХЛ П-1У А и Б стадиями процесса, получавшие ПХТ по схеме CHOP 14. Всего 6-8 введений. Выборка была квотированная.

Размеры первичной опухоли, данные рентенотомографических исследований, КТ и ЯМРТ, УЗИ, а также ОАК, биохимический анализ крови (ЛДГ и щелочная фосфата) и

RCHOP-14 кестесін В-жасаушы индолентті ходжкин емес лимфоманы қолдану

Мақсаты: Ходжкин емес лимфоманың индолентті түрін емдеу нәтижесін жақсарту.

Жұмыста 15 науқасты лимфоманың индолентті түрімен RCHOP-14 кестесі қолданылып, 80% науқаста толық ремиссия алынды, 20% - жартылай ремиссия, ауру қайталануы болған жоқ. Ал, бақылау тобында емдеу нәтижелері былай: толық ремиссия- 58%, жартылай ремиссия- 42,6 %, аурудың қайталануы- 26% құрады.

Применение схемы RCHOP-14 при лечении В-клеточных индолентных неходжкинских лимфом.

Целью исследования - улучшение результатов лечения больных с индолентной формой НХЛ.

Материалом исследования служили истории болезни 15 пациентов с индолентной формой НХЛ, получавшие ПХТ по схеме R CHOP-14 (основная группа), в качестве контроля служили больные (n=15), получавшие ПХТ по схеме CHOP 14.

Результаты наших исследований показывают, что в основной группе полная ремиссия процесса составила 80,0%, частичная - 20,0%, прогрессирование процесса не было. В контрольной группе результаты лечения оказались таковыми – 58,0 и 42,0%, соответственно, прогрессирование – у 26,0% больных. В основной группе качество жизни больных составило 2 балла.

Application scheme RCHOP-14 in the treatment of indolent B cell non-Hodgkin's lymphoma.

Karakulov R.K. Gabbasova S.T., Sagindykov G.A., Asanov A.A., Nassipov B.A., Kossenkov N.YU.

The aim of our study was to improve the treatment results of patients with indolent form of non-Hodgkins lymphoma.

Material studies were histories cases of 15 patients (n=15) with indolent form of non-Hodgkins lymphoma treated with polychemotherapy according to the scheme RCHOP-14 (main group) and patients who received polychemotherapy scheme CHOP-14, served as control. Our results shows that in the experimental group achieved a complete remission 80%, partial 20% of patients. Progression of the process is not registered. In the control group, the results have been established, 58% and 42.0%, respectively, the progression from 26.0% of patients. In the study group, the quality of life of patients was 2 points.

активность больного по шкале Карновского использовали в качестве первичных точек.

Вторичные конечные точки включали степень регрессии опухолей (полная, частичная регрессия) на основе данных уменьшения размеров опухоли, купирования симптомов

Таблица 1- Результаты лечения больных индолентной формой НХЛ

Количество больных	Полная ремиссия	Частичная ремиссия	Прогрессирование процесса
Основная (n=15)	12 (80,0%)	3 (20,0%)	0 (0,0%)
Контрольная (n=15)	6 (40,0%)	5 (34,0%)	4 (26,0%)
Примечание: $p < 0,05$			

интоксикации, улучшения данных рентгенологических исследований, КТ, ЯМРТ, УЗИ, показателей ОАК, биохимических исследований и степень активности по шкале Карновского.

Критерии включения: объектом исследования служили 15 пациентов (основная группа) с НХЛ П-1У А и Б стадиями заболевания с низкой степени злокачественности, находящиеся в отделении гемобластозов КазхНИИИиР. Из 15 больных мужчин составили 9, женщин – 6, возраст пациентов колебался от 21 до 72 лет. Всем пациентам было проведено гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследования. У 10 пациентов было зарегистрирована В-клеточная лимфоцитарная лимфома, у 2-х пациентов – экстранодальная MALT лимфома, в 3-х случаях – нодальная фолликулярная лимфома (1-П тип). При ИГХ исследований у всех больных было установлено экспрессия в опухоли CD 20 (+) антигена. Пациентами из основной группы была проведена ПХТ по схеме R CHOP – 14 (мабтера 375 мг/м², 1 день ЦФ 750 мг/м², винкрестин 1,4 мг/м², адрим 40 мг/м² (2 день), преднизалон 40 мг/м², 1-5 дни в/в. Больные контрольной группы получали ПХТ по схеме CHOP 14 (15 пациентов).

Оценка безопасности - предлагаемый метод воздействия (ПХТ по схеме R CHOP-14. переносили удовлетворительно, аллергических реакций не зарегистрированы.

Статистический анализ проведен с использованием статистической программы SPSS 10.0 для Windows.

Результаты и их обсуждение

Как видно из таблицы в основной группе, где пациенты получали ПХТ по схеме R CHOP – 14 полная ремиссия процесса достигнута у 80,0% пациентов, частичная – 20,0%, прогрессирование процесса не зарегистрировано. В контрольной группе (CHOP 14) полная ремиссия процесса была установлена только у 40,0% больных, частичная – у 34,0%, а прогрессирование – у 26,0% больных ($p < 0,05$).

В одном из первых клинических исследований 2 фазы мабтеры в комбинации с химиотерапией при вялотекущей НХЛ, у 28 пациентов установили объективный эффект (полная ремиссия составила 58,0%, частичная – 42,0%), причем медиана времени до прогрессирования заболевания превышала 7 лет (Czuczman et.al.2003).

Таким образом, сравнительный анализ результатов лечения с применением различных протоколов (GELA LNH) показывает преимущества режима мабтера плюс CHOP-14. Общая 2-х летняя выживаемость в группе мабтера плюс CHOP составила 70,0%, а в группе CHOP только 57,0%. В основной группе качество жизни больных повысилось на 2 балла, против контроля, где таковое составило 0-1 балл.

Список использованной литературы

1. Арзыкулов Ж.А и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009 г.- Алматы, 2010.
2. Поддубная И.В. Лечение индолентных неходжкинских лимфом //Практическая онкология.-2004.- Т.5, №3.
3. Czuczman A. et.al. Rituximab in combinatio with CHOP of fludarabine in low-grade lymphoma // Semin.Oncol- 2003.-Vol.29.-P. 36-40.